Paciente:

09-abr.-2025 15:53

Identificación del Paciente

Paciente			Doc. de identificación	
Fecha de Nacimiento		Edad	Sexo	Grupo Sanguineo
Estado Civil	Ocupación			
Teléfono Celular				
Dirección				
Responsable				

Llegada del Paciente

Ingreso al Servicio

Fecha y hora de Ingreso **11-ene.-2025 13:38**	Fecha y hora de Atención **11-ene.-2025 13:50**
El paciente se moviliza por sus propios medios? **Si**	Medio de trasporte
Estado de llegada **Alerta**	Procedencia **Domicilio**
Llegó remitido de	

Causa de Consulta y Anamnesis

Causa del evento: **" DENGUE"**
Fecha de ocurrencia: Tiempo de evolución: **4 Días** Tipo de evento: **Enfermedad General**
Tipo consulta PyP: Sito de ocurrencia:

Enfermedad Actual - (Anamnesis)

INGRESA PCTE DE 18 AÑOS DE EDAD CAMINANDO POR SUS MEDIOS EN COMPAÑIA DEL PADRE, PROCEDENTE DE CANDELARIA,POR CUADRO DE 4 DIAS CON CEFALEA, MIALGIAS, ARTRALGIAS, FIEBRE NO CUANTIFICADA, HIPOREXIA, NAUSEAS, VOMITO QUE CEDIÓ, DEPOSICIONES MUY BLANDAS, ACUDIÓ A PERIFERIA LE TOMARON LOS SIGUIENTES EXAMENES
10/01/2025: HEMOGRAMA: LEUCOS: 4000, N: 66.4% MON: 11.9% LINF: 21.7% HB: 17.2 GR HTO: 47.9% PLAQ: 39.000
IGM DENGUE: NEGATIVO
NS1: POSITIVO
11/01/2024: HEMOGRAMA: LEUCOS: 7100, N: 62.9% MON: 16.2% LINF: 20.9% HB: 17.9 GR HTO: 52.1% PLAQ: 23.000
NIEGA LA PRESENCIA DE SANGRADOS
MEDICO LE INDICA CONSULTAR EN NIVEL SUPERIOR

SE ATIENDE CON EPP

Atención Clínica

Antecedentes Personales

Patológicos	- niega(Reg: 12 Ene 2025 11:34:)
Patológicos	No Menciona Ningún Antecedente de Importancia para la Atención - (Reg: 21 Sep 2018 16:06:)
Patológicos	- NIEGA(Reg: 11 Ene 2025 14:06:)
Patológicos	No Menciona Ningún Antecedente de Importancia para la Atención - (Reg: 07 Ene 2020 15:04:)
Quirúrgicos	- SEPTOPLASTIA + TURBINOPLASTIA ENDOSCOPICA DIC 2013(Reg: 19 May 2015 14:58:)
Quirúrgicos	- septoplastia + turbinoplastia endoscopica dic 2013(Reg: 12 Ene 2025 11:34:)
Farmacológicos	- niega(Reg: 12 Ene 2025 11:34:)
Tóxicos	- NIEGA(Reg: 11 Ene 2025 14:06:)
Inmunologicos	- VACUNAS AL DIA(Reg: 21 Sep 2018 16:06:)
Otros	- dolor abdominal mesogastrio y hemicolon izquierdo(Reg: 02 Jun 2015 11:25:)

Antecedentes Familiares

		Mamá	Papá	Hno(a)	Abuelo(a)	Conyugue	Hijo(a)	Otros
Otros	- padred amsatico							
Otros	- asma padre							
Otros	- Abuela materna HTA DMellitus Abuelo materno NO dato Abuela paterna Colon irritable / hipotiroidismo Abuelo paterno Fumador Papa Gastritis / asma infantil / Rinitis alérgica Mama Estreñimiento Hijo Único							

Paciente: *09-abr.-2025 15:53*

Otros - - abuela materna hta dmellitus
abuelo materno no dato
abuela paterna colon irritable /
hipotiroidismo

Revisión por Sistemas

11 enero 2025 14:06 -

Observaciones. . . . . **Revisión por sistemas normal**

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: 08945
Identificación

12 enero 2025 11:33 -

Observaciones. . . . . **Revisión por sistemas normal**

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

Examen Físico

11 enero 2025 14:06 - *(URG P1)*

Estado General. . . . . **CON FEBRICULA**
TRANQUILO Y COLABORADOR

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional:
Identificación

12 enero 2025 11:33 -

Estado General. . . . . **tranquilo .**

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

14 enero 2025 00:11 - *(PISO 8 (TORRE NORTE) HOSP)*

Estado General. . . . . **Buenas condiciones generales luce bien sin disnea sin dolor sin fiebre**

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación CC

11 enero 2025 14:06 - *(URG P1)*

Cabeza. . . . . **NORMOCEFALICO, PUPILAS ISOCÓRICAS, REACTIVAS A LA LUZ.**

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional:
Identificación

12 enero 2025 11:33 -

Cabeza. . . . . **semiología normal**

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

11 enero 2025 14:06 -

Boca y Faringe. . . . . **LASERACION EN LABIOS**

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional:
Identificación

12 enero 2025 11:33 -

Boca y Faringe. . . . . **semiología normal**

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

14 enero 2025 00:11 -

Boca y Faringe. . . . . Normal

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

11 enero 2025 14:06 -

Cuello. . . . . **MOVIL, NO ADENOPATIAS**

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional:
Identificación

12 enero 2025 11:33 -

Cuello. . . . . **semiología normal**

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

14 enero 2025 00:11 -

Cuello. . . . . Normal

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

Paciente: *09-abr.-2025 15:53*

11 enero 2025 14:06 -
Otorrinolaringología. . . . . Normal
Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación
12 enero 2025 11:33 -
Otorrinolaringología. . . . . Normal
Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

14 enero 2025 00:11 - *(*
Otorrinolaringología. . . . . Normal
Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

11 enero 2025 14:06 - Tórax.
. . . . . **TORAX SIMETRICO,RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS, REGULARES, SIN SOPLOS. MURMULLO VESICULAR PRESENTE EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, SIN SOBREAGREGADOS.**
Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación
12 enero 2025 11:33 -
Tórax. . . . . **ruidos cardiacos ritmicos, no soplos**
murmullo vesicular presente no agregados
Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional:Identificación

14 enero 2025 00:11 -
Tórax. . . . . **Ruidos cardiacos rítmicos no soplos**
Campos pulmonares ventilados sin agregados
Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

11 enero 2025 14:06
-Abdomen. . . . . **BLANDO, DEPRESIBLE, NO MASAS, NO MEGALIAS, DOLOROSO CON LA PALPACION DE EPIGASTRIO E HIPOCONDRIO DER, SIN SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL. PUÑOPERCUSIÓN BILATERAL NEGATIVA.**
Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación
12 enero 2025 11:33 -
Abdomen. . . . . **blando , depresible , no Cullen , no grey Turner , no masa**
Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

14 enero 2025 00:11 -
Abdomen. . . . . **Blando depresible no doloroso a la palpación**
Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

11 enero 2025 14:06 -
Genito - Urinario. . . . . **NO SE EXPLORA**
Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación
12 enero 2025 11:33 -
Genito - Urinario. . . . . **sin lesiones**
Firmado electrónicamente por- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

14 enero 2025 00:11 -
Genito - Urinario. . . . . **Se omite**
Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

11 enero 2025 14:06 -
Musculo-esquelético. . . . . **SIMETRICAS, NO EDEMAS**
LLENADO CAPILAR <2 SEG
Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación
12 enero 2025 11:33 -

Paciente: 09-abr.-2025 15:53

Musculo-esquelético. . . . . **no signos de compromiso neurovascular**

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

14 enero 2025 00:11 -

Musculo-esquelético. . . . . **Mov sin edemas llenado capilar menor 3 seg**

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

11 enero 2025 14:06 -

(Neurológico. . . . . **ALERTA, ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS MENTALES, SIN DETERIORO NEUROLOGICO, NO ALTERACION DE SUS PARES CRANEALES,MIMICA FACIAL CONSERVADA, GLASGOW 15/15**

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

12 enero 2025 11:33 -

Neurológico. . . . . **semiología normal**

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional:

14 enero 2025 00:11 -

Neurológico. . . . . **No déficit , Glasgow 15/15**

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

11 enero 2025 14:06 - Piel. . .

. . . . . **RUBICUNDEZ**
PRESENCIA DE PETEQUIAS EN MSIS

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

12 enero 2025 11:33 -

Piel. . . . . **Rash generalizado**
petequias en miembros inferiores

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

11 enero 2025 14:06 -

(Analisis. . . . . **PCTE DE 18 AÑOS DE EDAD CON CUADRO DE 4 DIAS CON MALESTAR GENERALIZADO, DIAGNOSTICADO EN PERIFERIA CON DENGUE, APORTA HEMOGRAMA DE HOY CON PLAQUETAS EN 23MIL, NIEGA SANGRADOS, SIN EMBARGO AL EXAMEN FISICO CON PETEQUIAS Y CON DOLOR ABDMINAL CON LA PALPACION DE HIPOCONDRIO DER,SE INGRESA PARA TOMA DE PARACLINICOS, LEV, MANEJO MEDICO, SE DEJA EN OBSERVACION, SE COMENTARA CON MEDICINA INTERNA, LES EXPLICO LA CONDUCTA**
SEMAFORIZACION: VERDE

Firmado electrónicamente por - MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

12 enero 2025 11:33 -

Analisis. . . . . **Paciente en contexto de dengue con signos de alarma en fase crítica, NS1 positivo, DIA 4 , HOY plaquetas de 19.000 previas de p´laq: 23.000, HCT 48% ,transaminitis, INR limite superior , (alto riesgo disfuncion hepatocelular) , sin manifestacion de sangrado , variables macro - hemodinamicas en metas . se indica renimacion dirigida por volumen ,indicado seguimiento de variables hematologicas HCT - plt - funcion hepatocelular . Toldillo para cama adulto . monitoria UCIN.**

Dx:
1. Dengue con signos de alarma
- Dolor abdominal.

Firmado electrónicamente por - NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

14 enero 2025 00:11 -

Analisis. . . . . **Paciente con dengue con sg de alarma, con estancia 24 hrs en uci. hemogramas con evidencia de tendencia a recuperación plaquetaria. Completò manejo y vigilancia en unidad intermedia. Traslado a sala de hospitalizaciòn a cargo de medicina interna. se disminuye aporte de LEV, se retira aislamiento**

Paciente: *09-abr.-2025 15:53*

Dx
1 Dengue con signos de alarma
- Dolor abdominal y cefalea
2 Hepatitis por dengue

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

11 enero 2025 14:06 -
Observaciones. . . . . **Revisión por sistemas normal**

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

12 enero 2025 11:33 -
Observaciones. . . . . **Revisión por sistemas normal**

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

11 enero 2025 14:06 -
Triage. **3**

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

12 enero 2025 11:33 -
Triage. **3**

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

Diagnósticos Ingreso **Localización** **Tipo DX**

-- (A90X) FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO] Impresion Diagnóstica

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

-- (A91X) FIEBRE DEL DENGUE HEMORRAGICO Impresion Diagnóstica

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

-- (A90X) FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO] Impresion Diagnóstica

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

-- (A90X) FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO] Impresion Diagnóstica

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA INTERNA Tarjeta Profesional: Identificación

Evoluciónes

11 enero 2025 16:40 -

Día de Hospitalización No.

EVOLUCION
PCTE CON DENGUE GRAVE
COMENTO CON LA DRA GARTNER INTERNISTA DE TURNO, VALORARÁ
SEMAFORIZACION: AMARILLA

Análisis de Resultados de Exámenes

902210 HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO: LEUCOPENIA
Recuento de Leucocitos - 7.87
Neutrófilos # - 3.47
Neutrófilos % - 44.1
Linfocitos # - 2.34
Linfocitos % - 29.7
Monocitos # - 0.57
Monocitos % - 7.2
Eosinófilos # - 0.02
Eosinófilos % - 0.3
Basófilos # - 0.03
Basófilos % - 0.4

Paciente: *09-abr.-2025 15:53*

Recuento de Eritrocitos - 6.87
Hemoglobina - 19.6
Hematocrito - 55.6
Volumen corpuscular medio - 80.9
Hemoglobina corpuscular media - 28.5
Concentración de Hemoglobina corpuscular media - 35.3
Ancho de distribución eritrocitario DS - 37.2
Ancho de distribución eritrocitario CV - 13.2
Recuento de plaquetas - 20
Volumen medio plaquetario - 10.3
Fracción de plaquetas inmaduras - 7.8
Normoblastos # - 0.050
Normoblastos % - 0.6
Granulocitos Inmaduros # - 1.4400
Granulocitos Inmaduros % - 18.300

903895 CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS: Creatinina en suero - 1.09
NORMAL

903856 NITROGENO UREICO: Nitrógeno Uréico en Suero. - 10.4
Úrea en suero - 22.2
NORMAL

902045 TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]: PROLONGADOS
Tiempo de Protrombina - 14.3
Indice Normalizado Internacional INR - 1.37
Indice de Sensibilidad Internacional ISI - 1.09
Tiempo de Protrombina del pool de la población - 10.7
Indice Normalizado Internacional del pool de la población - 1.0

902049 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]: Tiempo de tromboplastina parcial activado - 42.9
Tiempo de Tromboplastina Parcial del pool de la población - 28.2
PROLONGADO

903841 GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA: Glicemia en ayunas - 85
NORMAL

903866 TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]: Transaminasa pirúvica ALAT - 166
ELEVADA

903867 TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]: Transaminasa oxaloácetica ASAT - 220
ELEVADA

903833 FOSFATASA ALCALINA: Fosfatasa alcalina. - 87.00
NORMAL

903809 BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA: NORMAL
Bilirrubina Total. - 1.09
Bilirrubina Indirecta. - 0.43
Bilirrubina Directa. - 0.66

903110 ACIDO LACTICO [L-LACTATO] SEMIAUTOMATIZADO: Acido Láctico - 4.10
ELEVADA

Tipo Estancia: Evolución Urgencias
Criterio: Paciente que requiere valoración por alguna especialidad

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional:
Identificación

Notas de Interconsulta

11 enero 2025 17:04 -

MEDICINA INTERNA

Paciente: *09-abr.-2025 15:53*

Dx:
1. Dengue con signos de alarma
- Dolor abdominal.

Subjetivo:
Paciente refiere malestar general. Niega sangrados. Última alza térmica el 09/01.

Examen físico:
Peso 92 kg
No IY
Auscultación cardiopulmonar normal
Abdomen blando, depresible, dolor a la palpación de epigastrio.
No edema
Rash generalizado
petequias en miembros inferiores
Alerta, orientado, sin focalización.

Estudios:
10/01/2025: LEUCOS: 4000, N: 66.4% MON: 11.9% LINF: 21.7% HB: 17.2 GR HTO: 47.9% PLAQ: 39.000
IGM DENGUE: NEGATIVO
NS1: POSITIVO
11/01/2024: HEMOGRAMA: LEUCOS: 7100, N: 62.9% MON: 16.2% LINF: 20.9% HB: 17.9 GR HTO: 52.1% P´LAQ: 23.000

Análisis:
Paciente de 18 años con dengue con signos de alarma en fase crítica, con cuadro de 4 días de fiebre, mialgias, cefalea, náuseas y deposiciones blandas, con NS1 positivo. Laboratorios de ingreso con trombocitopenia severa, hiperlactatemia y hemoconcentración, se inician LEV a 3 cc/kg/hora, y revalorar. Laboratorios de control en 6 horas. En el momento estable, sin sangrados. Se deja en observación clínica.

Plan:
Observación
SSN 0.9%, pasar 1000 cc ahora IV en la primera hora, luego continuar a 250 cc/hora IV.
Tomar en 6 horas: hemograma y lactato
Revaloración con resultados en la noche
CSV
Se dió información al paciente/familia sobre la condición clínica, evolución y plan de manejo

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA INTERNA Tarjeta Profesional:
Identificación

Evoluciónes

11 enero 2025 17:29 -

Día de Hospitalización No.1

Diagnósticos:
(A90X) FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]
Se dió información al paciente/familia sobre la condición clínica, evolución y plan de manejo

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

11 enero 2025 19:34 -

Día de Hospitalización No.1

Diagnósticos:
(A90X) FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]

DIAGNOSTICOS
DENGUE

MANEJO RINGER A 250 cc HORA

PACIENTE REFIERE TOLERA INGESTA ALIMENTOS DE SOLIDOS Y LIQUIDOS
SIN EMESIS
DIRUESIS DISMINUIDA

Paciente: 09-abr.-2025 15:53

LIGERO DOLOR PEIGASTRICO
MUCOSAS HUMEDAS
DISMINUCION DE MURMULLO EN BASE DERECHA

PLAN
MANEJ CON CRISTALOIDES PARA HIDRATACION

Tipo Estancia: Hospitalización
Criterio: Paciente con patología que requiera seguimiento clínico por tiempo superior a 6 horas

Presión Arterial: 118/81
Pulso: 95/min
Frec. Resp.: 19/min
Temperatura: 37.5°C
Sat. Oxígeno: 96
Peso: 92Kg.
Talla: 1.75mts
SC: 2.11
EVA: 4

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA INTERNA Tarjeta Profesional: Identificación

12 enero 2025 08:51 -

Día de Hospitalización No.2

Diagnósticos:
(A90X) FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]

Tipo Estancia: Hospitalización
Criterio: Paciente que requiera tratamiento médico prolongado con medicaciones endovenosas

MEDICINA INTERNA
DR RODRIGUEZ

Dx:
1. Dengue con signos de alarma
- Dolor abdominal.

Subjetivo:
Paciente refiere malestar general. Niega sangrados. Última alza térmica el 09/01.

Examen físico:
Peso 92 kg
No IY
Auscultación cardiopulmonar normal
Abdomen blando, depresible, dolor a la palpación de epigastrio.
No edema
Rash generalizado
petequias en miembros inferiores
Alerta, orientado, sin focalización.

Estudios:
12.1.25
LEUCOS DE 6640 NEUTROS DE 1890 LINFOS DE 2870
HGB DE 16.4 PLAQUETAS DE 19.000 previas de 20.000
10/01/2025: LEUCOS: 4000, N: 66.4% MON: 11.9% LINF: 21.7% HB: 17.2 GR HTO: 47.9% PLAQ: 39.000
IGM DENGUE: NEGATIVO
NS1: POSITIVO
11/01/2024: HEMOGRAMA: LEUCOS: 7100, N: 62.9% MON: 16.2% LINF: 20.9% HB: 17.9 GR HTO: 52.1% P´LAQ: 23.000

Análisis:
Paciente de 18 años con dengue con signos de alarma en fase crítica, con cuadro de 4 días de fiebre, mialgias, cefalea,

Paciente: 09-abr.-2025 15:53

náuseas y deposiciones blandas, con NS1 positivo. hoy con caida de plaquetas a 19.000 no sangrado, persiste con dolor abdominal, considero monitoria ucin
Se dió información al paciente/familia sobre la condición clínica, evolución y plan de manejo

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA INTERNA Tarjeta Profesional: Identificación

12 enero 2025 11:12 -

Día de Hospitalización No.1

ingreso UCIN dia

Dx:
1. Dengue con signos de alarma
- Dolor abdominal.

historia clinica documenta cuadro de 4 días de fiebre, mialgias, cefalea, náuseas y deposiciones blandas, con NS1 positivo. hoy con caida de plaquetas a 19.000 no sangrado, persiste con dolor abdominal

ucin
requerimiento de monitoria hemodinámica

problemas
transaminitis
INR limite superior
trombocitopenia severa

soportes
renimacion dirigida por volumen

microbiologicos
igm dengue: negativo ns1: positivo

paraclinicos
12.01.25leucos de 6640 neutros de 1890 linfos de 2870 hgb de 16.4 plaquetas de 19.000 previas de 20.000 , transaminitis
10/01/2025: leucos: 4000, n: 66.4% mon: 11.9% linf: 21.7% hb: 17.2 gr hto: 47.9% plaq: 39.000
igm dengue: negativo ns1: positivo
11/01/2024: hemograma: leucos: 7100, n: 62.9% mon: 16.2% linf: 20.9% hb: 17.9 gr hto: 52.1% p´laq: 23.000

subjetivo - paciente tranquilo. no dolor. niega sangrados. tolera via oral .

Examen físico:
fc 70 tam 65 mmhg glicemias 101 mg dl
fio2 21 % sat 98%
tolerando via oral .

Peso 92 kg
No IY
Auscultación cardiopulmonar ruidos cardiacos ritmicos , no soplos , no r3 r4 .
pulmonar . mv +. no sibilanicas , no estertores.
Abdomen blando, depresible, dolor a la palpación de epigastrio.
No edema
Rash generalizado
petequias en miembros inferiores
Alerta, orientado, sin focalización.

Análisis:
Paciente en contexto de dengue con signos de alarma en fase crítica, NS1 positivo, DIA 4 , HOY plaquetas de 19.000 previas de p´laq: 23.000, HCT 48% ,transaminitis, INR limite superior , (alto riesgo disfuncion hepatocelular) , sin manifestacion de sangrado , variables macro - hemodinamicas en metas . se indica renimacion dirigida por volumen ,indicado seguimiento de variables hematologicas HCT - plt - funcion hepatocelular . Toldillo para cama adulto . monitoria UCIN.

Cuidado integral de paciente critico en UCIN

Paciente: 09-abr.-2025 15:53

Toldillo para cama adulto
Cabecera a 30°
Dieta normal
Monitoría no invasiva de signos vitales cada 2 horas
Control estricto de líquidos administrados, eliminados, cuantificar diuresis
Monitoría EKG
Profilaxis anti TVP: No
Gastroprotección: IBP
Analgesia: Acetaminofen
Antimicrobianos/cultivos: no
Cuidados propios de enfermería y medidas de confort
Medidas de prevención: higiene oral, cuidados de piel, barandas en alto
glucometría de ingreso.

Metas
TAM 65-75 mmHg
Diuresis mayor a 0.5cc/kg/h
Control de dolor EVA menor de 4
SatO2 mayor de 9%
Glucometría 80-140 mg/dl

Plan
liquidos endovenosos ringer a 150 ml hora .
indicado seguimiento de variables hematologicas HCT - plt - funcion hepatocelular .

Dr. christian quintero MD/UCI .
Se dió información al paciente/familia sobre la condición clínica, evolución y plan de manejo
Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

12 enero 2025 17:40 -
Día de Hospitalización No.1

paraclínicos control

Recuento de Leucocitos 7.76 x10^3/uL
Neutrófilos # 2.38 x10^3/uL
Neutrófilos % * 30.6 %
Linfocitos # * 3.66 x10^3/uL
Linfocitos % 47.2 %
Hemoglobina 16.4 g/dL
Hematocrito 47.4 %
Recuento de plaquetas * 21 ** discreto aumento

Tipo Estancia: UCIN
Criterio: Varios: Pacientes hemodinámicamente estables en fase de recuperación de falla renal aguda, con monitoría de PVC, reemplazo de lo eliminado según valores PVC y diuresis
Día de Hospitalización No.1

paraclínicos de control noche
Dr. christain quintero md/uci
Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

12 enero 2025 21:58 -
Día de Hospitalización No.1

EVOLUCION UCIN NOCHE

JUAN MIGUEL CAICEDO
EDAD 18 AÑOS

DX:
1. DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA

Paciente: 09-abr.-2025 15:53

- DOLOR ABDOMINAL.
2.HEPATITIS POR DENGUE

UCIN
-TROMBOCITOPENIA SEVERA RIESGO DE SANGRADO MAYOR
-REQUERIMIENTO DE MONITORIA HEMODINÁMICA

PROBLEMAS
-TROMBOCITOPENIA SEVERA
-TRANSAMINITIS
-HIPERLACTATEMIA EN DEPURACION
-RIESGO DE SANGRADO MAYOR

SOPORTES
NO

MICROBIOLOGICOS
-IGM DENGUE: NEGATIVO NS1: POSITIVO

HEMODINAMICO PACIENTE SIN SOPORTE VASOACTIVO CON SIGNOS VITALES FC 72XMIN TA 118/69 TAM 84 RUIDOS CARDIACOS RITMICOS NO SOPLOS, TROMBOCITOPENIA SEVERA EN ASCENSO SIN EVIDENCIA DE SANGRADO, HEMOCONCENTRACION
RESPIRATORIO PACIENTE SIN VM CON FR 20XMIN SATO2 97% RUIDOS RESPIRATORIOS PRESENTE SIN SOBREAGREGADOS SIN DISNEA
INFECCIOSO PACIENTE SIN PICOS FEBRILES CON TMAX 36.6°C SIN SIGNOS DE SIRS
METABOLICO GLUCOMETRIA 91 TOLERANDO LA VIA ORAL SIN DOLOR ABDOMINAL SIN IRIRTACION PERITONEAL, TRANSAMINITIS
RENAL GU 2.7 CC KG HORA AZOADOS NORMALES
NEUROLOGICO CONSCIENTE ALERTA SIN DEFICIT NEUROLOGICO

ECO ABDOMINAL TOTAL
Derrame pleural derecho.
2. Líquido libre intraabdominal, que predomina hacia la excavación pélvica.
3. Pseudoengrosamiento las pared vesicular es, por patología de base.
4. Esteatosis hepática difusa leve.

ANÁLISIS:
PACIENTE DE 18 AÑOS DE EDAD QUIEN INGRESA EN CONTEXTO DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA EN FASE CRÍTICA, NS1 POSITIVO, DIA 4 , CON TROMBOCITOPENIA SEVERA Y HEPATITIS POR DENGUE, ACTUALMENTE EN CONDICIONES ESTABLES SIN SOPORTE VASOACTIVO NI VENTILATORIO, TROMBOCITOPENIA EN ASCENSO AUNQUE AUN FUERA DE RANGOS DE SEGURIDAD, HEMOCONCENTRACION EN MEJORIA, LACTATO EN DEPURACION, SIN TRASTORNO HIDROELECTROLITICO, TRANSAMINITIS, MEJORIA DEL DOLOR ABDOMINAL SIN DETERIORO DE LA FUNCION RENAL SIN DETERIORO NEUROLOGICO

SE CONSIDERA CONTINUAR IGUAL MANEJO INSTAURADO SE SOLICITA PARACLINICOS DE CONTROL CONTINUA MANEJO EN UCIN

Diagnósticos:
(A91X) FIEBRE DEL DENGUE HEMORRAGICO

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA DE URGENCIAS Tarjeta Profesional: Identificación

13 enero 2025 08:53 -
Día de Hospitalización No.2

NOTA DIA
DRA CAMACHO, DR DEVIA.

1. DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA
- DOLOR ABDOMINAL.
2. HEPATITIS POR DENGUE

Justificación UCIN/Problemas: Fase crítica de Dengue, alto riesgo sangrado espontáneo, inestabilidad eléctrica y

Paciente: 09-abr.-2025 15:53

hemodinámica.

Soportes: Infusión LEV
Invasivos: no
Microbiologicos: IgM dengue: negativo ns1: positivo
Se siente en buena condición general, no historia de sangrados activos.
Paraclínicos: Leucos 5840, neutros 17%, monos 6,7%, Hb 15.7, Hto 45.8, cociente Hto/Hb 2,9 sin hemoconcentración, Plaquetas 25000, linfos reactivos 62%, BBT 0.54, BI 0.24, BD 0.3, AST 171, ALT 154, Na 142, K 4.19
CV: TA 134/80, FC 61, no alteración en perfusión distal. no soplos ni galope. llenado capilar 2 seg
Res: FR 21%, Sat 95%, no agregados pulmonares
Hem: no evidencia de sangrado mayor activo
Infecto: Afebril, no signos inflamatorios infecciosos en sitios de punción
GU: diuresis positiva 3.4cc/kg/h, Balance negativo 2.2lt, con aporte IV alto, al igual que oral. No signos de deshidratación.
GI: no masas, no signos de irritación peritoneal. No deposición. No hepatomegalia palpable hoy.
Metabólico: Glucometría 91mg, recibe y tolera vía oral.
eco abdominal total
derrame pleural derecho.
2. Líquido libre intraabdominal, que predomina hacia la excavación pélvica.
3. Pseudoengrosamiento las pared vesicular es, por patología de base.
4. Esteatosis hepática difusa leve.

Análisis:
Paciente de 18 años de edad en primer dia de internación en UCIN. Tiene dengue con signos de alarma en fase crítica. NS1 positivo hoy dìa 5. Trombocitopenia severa obligó a manejo en unidad intensiva, sin embargo exhibe mejorìa progresiva. Se hará control hemograma en la tarde, se continúa hidratación. Vigilancia clínica y riesgo de sangrado le hacen meritorio de vigilancia en intermedia como se ha descrito.

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional:Identificación

13 enero 2025 16:02 -
Día de Hospitalización No.2

Diagnósticos:
(A91X) FIEBRE DEL DENGUE HEMORRAGICO

NOTA TARDE
Leucos 5140, neutros 28%, linfos 54%, monos 9,7% Hb 15,5, Hto 45.8 cociente Hb/Hto 2,9, RDW 13, plaquetas 40000 en aumento. neutros en banda 2%, linfos reactivos 12%.
2 hemogramas con evidencia de tendencia a recuperación plaquetaria. Completò manejo y vigilancia en unidad intermedia. Traslado a sala de hospitalizaciòn a cargo de medicina interna. se disminuye aporte de LEV, se retira aislamiento. Explico a paciente y padre, reportan entender.

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

14 enero 2025 00:34 -
Día de Hospitalización No.1

Se carga orden medica

Firmado electrónicamente por - MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

14 enero 2025 09:06 -
Día de Hospitalización No.1

Diagnósticos:
(A90X) FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]

Diagnósticos:
1 Dengue con signos de alarma
- Dolor abdominal y cefalea
2 Hepatitis por dengue

Paciente: 09-abr.-2025 15:53

Reporte de Paraclinicos:
ALT 115 AST 111 Leucos 4870 N 910 Hb 15.8 Hto 45.0 Plt 65000
Transaminasas elevadas pero en descenso, hemograma sin leucocitosis, trombocitopenia en ascenso.
Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

14 enero 2025 13:53 - (
Día de Hospitalización No.1

Diagnósticos:
(A90X) FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]

MEDICINA INTERNA

DIAGNOSTICOS
DENGUE
SIGNOSDE ALARMA CORREGIDOS

PACIENTE TOLERA INGESTA ALIMENTOS DE SOLIDOS Y LIQUIDOS
SIN EMESIS
DIRUESIS ADECUADA

EXAMEN FISICO
ALERTA
MUCOSAS HUMEDAS
SIN ESTERTORES
ABDOMEN BLANDO
SIN EDEMAS

PLAN
PACIENTE CN DENGUE, INCREMENTO DE PALQUETAS
POSIBLE EGRESO EN 24 HORAS

Tipo Estancia: Hospitalización
Criterio: Hospitalización

Presión Arterial: 142/81
Pulso: 95/min
Frec. Resp.: 16/min
Temperatura: 36.2°C
Sat. Oxígeno: 94
EVA: 0
Firmado electrónicamente por -- MEDICINA INTERNA Tarjeta Profesional: Identificación

15 enero 2025 07:05 -
Día de Hospitalización No.2

Diagnósticos:
(A90X) FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]

MEDICINA INTERNA

DIAGNOSTICOS
DENGUE CON SEROSITIS
SIGNOSDE ALARMA CORREGIDOS

PACIENTE ASINTOMATICO

EXAMEN FISICO
ALERTA
MUCOSAS HUMEDAS
SIN ESTERTORES

Paciente: *09-abr.-2025 15:53*

ABDOMEN BLANDO
SIN EDEMAS

HEMOGRAM HOY PALQUETAS EN 116.000 AYER 68.000

PLAN
PACIENTE CON DENGUE GRAVES, YA RESUELTO
SE DEFINE ERESO

Tipo Estancia: Hospitalización
Criterio: Paciente que requiera tratamiento médico prolongado con medicaciones endovenosas

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA INTERNA Tarjeta Profesional: Identificación

15 enero 2025 08:08 -

Día de Hospitalización No.2

Diagnósticos:
(A90X) FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]
(A90X) FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]

diagnósticos:
1 Dengue con signos de alarma
- Dolor abdominal y cefalea
2 Hepatitis por dengue

Reporte de praclinicos:
Leucos 5260 N 1140 Hb 15.3 Hto 43.3 Plt 116000
Sin leucocitosis, plt en ascenso.

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

Ordenes Medicas

11 enero 2025 14:08 - *(URG P1)*

*	(Hora: 14:08) 902045 TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]	Ubicación **No Aplica**
*	(Hora: 14:08) 902049 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP]	Ubicación **No Aplica**
*	(Hora: 14:08) 902210 HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO	Ubicación **No Aplica**
*	(Hora: 15:33) 903110 ACIDO LACTICO [L-LACTATO] SEMIAUTOMATIZADO	Ubicación **No Aplica**
*	(Hora: 14:09) 903809 BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA	Ubicación **No Aplica**
*	(Hora: 14:08) 903833 FOSFATASA ALCALINA	Ubicación **No Aplica**
*	(Hora: 14:08) 903841 GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	Ubicación **No Aplica**
*	(Hora: 14:08) 903856 NITROGENO UREICO	Ubicación **No Aplica**
*	(Hora: 14:08) 903866 TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]	Ubicación **No Aplica**
*	(Hora: 14:08) 903867 TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]	Ubicación **No Aplica**
*	(Hora: 14:08) 903895 CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	Ubicación **No Aplica**

Paciente:

09-abr.-2025 15:53

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional:
Identificación

11 enero 2025 15:33 -

* (Hora: 15:33) 871121 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA O AP Y LATERALDECUBITOLATERALOBLICUAS O LATERAL)CONBARIO Ubicación **No Aplica**
Observaciones DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional:
Identificación

11 enero 2025 15:34 -

* (Hora: 15:34) 881302 ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL Ubicación **No Aplica**
Observaciones DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA, DOLOR EN HCD

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional:
Identificación

11 enero 2025 16:46 -

* (Hora: 16:46) 890466 INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA (MEDICINA INTERNA) Ubicación **No Aplica**

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional:
Identificación

11 enero 2025 17:05 -

* (Hora: 17:05) 902210 HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO Ubicación **No Aplica**
Observaciones 11 pm

* (Hora: 17:05) 903110 ACIDO LACTICO [L-LACTATO] SEMIAUTOMATIZADO Ubicación **No Aplica**
Observaciones 11 pm

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA INTERNA Tarjeta Profesional:
Identificación

11 enero 2025 22:06 -

* (Hora: 22:06) 129A01E INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION INDIVIDUAL (INCLUYE AISLAMIENTO ESPECIAL) Ubicación **No Aplica**
Observaciones A CARGO D EMEDICINA INTERNA

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

12 enero 2025 08:54 -

* (Hora: 08:54) 110A01 INTERNACION EN UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTOS Ubicación **No Aplica**
Observaciones CUIDADOS INTERMEDIOS

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

12 enero 2025 12:11 -

* (Hora: 12:11) 902210 HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO Ubicación **No Aplica**

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

12 enero 2025 17:41 -

* (Hora: 17:41) 902210 HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO Ubicación **No Aplica**

* (Hora: 17:41) 903809 BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA Ubicación **No Aplica**

* (Hora: 17:41) 903859 POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS Ubicación **No Aplica**

Paciente: *09-abr.-2025 15:53*

* (Hora: 17:41) 903864 SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS Ubicación **No Aplica**

* (Hora: 17:41) 903866 TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA] Ubicación **No Aplica**

* (Hora: 17:41) 903867 TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA] Ubicación **No Aplica**

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

13 enero 2025 08:53 -

* (Hora: 08:53) 902210 HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO Ubicación **No Aplica**

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

13 enero 2025 16:12 -

* (Hora: 16:12) 902210 HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO Ubicación **No Aplica**

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

14 enero 2025 00:11 -

* (Hora: 00:11) 902210 HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO Ubicación **No Aplica**

* (Hora: 00:11) 903866 TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA] Ubicación **No Aplica**

* (Hora: 00:11) 903867 TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA] Ubicación **No Aplica**

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

14 enero 2025 13:53 -

* (Hora: 13:53) 902210 HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO Ubicación **No Aplica**

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA INTERNA Tarjeta Profesional: Identificación

15 enero 2025 07:06 -

* (Hora: 07:06) 902210 HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO Ubicación **No Aplica**
  Observaciones CONTROL EN 10 DIAS

* (Hora: 07:07) 903866 TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA] Ubicación **No Aplica**

* (Hora: 07:07) 903867 TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA] Ubicación **No Aplica**

* (Hora: 07:07) 903895 CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS Ubicación **No Aplica**

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA INTERNA Tarjeta Profesional: Identificación

15 enero 2025 07:07 -

* (Hora: 07:07) 890266 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA Ubicación **No Aplica**
  Observaciones CONTROL EN 2 SEMANAS

Paciente: *09-abr.-2025 15:53*

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA INTERNA Tarjeta Profesional: Identificación

11 enero 2025 14:06 -

* DOLEX 500 mg TABLETA RECUBIERTA **Dosificación**: 1 GRAMO
  CUM: 20068891-02 IUM:
  Observaciones: ORAL CADA 8 HORAS DURANTE 3 DÍAS

* LACTATO DE RINGER SOLUCION INYECTABLE BOLSA x 1.000 mL REF:ARB2324 **Dosificación**:
  Observaciones: ENDOVENOSA CADA 1.00 HORAS DURANTE 1 DÍAS PASAR 1000 CC EN BOLO Y DEJAR A 250 CC / HORA

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

11 enero 2025 19:35 - *(URG P1)*

* LACTATO DE RINGER SOLUCION INYECTABLE BOLSA x 1.000 mL REF:ARB2324 **Dosificación**:
  Observaciones: ENDOVENOSA CADA 1 HORAS DURANTE 1 HASTA NUEVA ORDEN

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA INTERNA Tarjeta Profesional: Identificación

12 enero 2025 11:12 -

* DOLEX 500 mg TABLETA RECUBIERTA **Dosificación**: 1 GRAMO
  CUM: 20068891-02 IUM:
  Observaciones: ORAL CADA 8.00 HORAS DURANTE 1 DÍAS *

* LACTATO DE RINGER SOLUCION INYECTABLE BOLSA x 1.000 mL REF:ARB2324 **Dosificación**:
  Observaciones: ENDOVENOSA CADA 1.00 INFUSIÓN CONTINUA DURANTE 1 DÍAS *

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

13 enero 2025 08:53 -

* DOLEX 500 mg TABLETA RECUBIERTA **Dosificación**: 1 GRAMO
  CUM: 20068891-02 IUM:
  Observaciones: ORAL CADA 8 HORAS DURANTE 1 DÍAS *

* LACTATO DE RINGER SOLUCION INYECTABLE BOLSA x 1.000 mL REF:ARB2324 **Dosificación**:
  Observaciones: ENDOVENOSA CADA 1 INFUSIÓN CONTINUA DURANTE 1 DÍAS *

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

13 enero 2025 16:03 -

* LACTATO DE RINGER SOLUCION INYECTABLE BOLSA x 1.000 mL REF:ARB2324 **Dosificación**:
  Observaciones: ENDOVENOSA CADA 1.00 INFUSIÓN CONTINUA DURANTE 1 DÍAS reducir dosis

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

14 enero 2025 00:13 -

* DOLEX 500 mg TABLETA RECUBIERTA **Dosificación**: 1 GRAMO
  CUM: 20068891-02 IUM:
  Observaciones: ORAL CADA 8.00 HORAS DURANTE 1 DÍAS solo a necesidad
  Suspendido por: .

* LACTATO DE RINGER SOLUCION INYECTABLE BOLSA x 1.000 mL REF:ARB2324 **Dosificación**:
  Observaciones: ENDOVENOSA CADA 1.00 INFUSIÓN CONTINUA DURANTE 1 DÍAS

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

14 enero 2025 00:34 -

* ACETAMINOFÉN 500 MG TABLETA (ACETAMINOFEN 500 mg TABLETA) **Dosificación**: 1 GRAMO
  CUM: 053560-05 IUM:
  Observaciones: ORAL CADA 8 HORAS DURANTE 0 HASTA NUEVA ORDEN

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

11 enero 2025 14:08 -

(Cabecera a 30 grados

Paciente:

Control de signos vitales
Curva térmica
Vigilar sangrado
Otras ordenes: COLOCAR TOLDILLO

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional:
Identificación

11 enero 2025 17:29 -

Dieta completa

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

12 enero 2025 11:13 -

Cuidado integral de paciente critico en UCIN
Toldillo para cama adulto
Cabecera a 30°
Dieta normal
Monitoría no invasiva de signos vitales cada 2 horas
Control estricto de líquidos administrados, eliminados, cuantificar diuresis
Monitoría EKG
Profilaxis anti TVP: No
Gastroprotección: IBP
Analgesia: Acetaminofen
Antimicrobianos/cultivos: no
Cuidados propios de enfermería y medidas de confort
Medidas de prevención: higiene oral, cuidados de piel, barandas en alto
glucometría de ingreso.

Metas
TAM 65-75 mmHg
Diuresis mayor a 0.5cc/kg/h
Control de dolor EVA menor de 4
SatO2 mayor de 9%
Glucometría 80-140 mg/dl

Plan
liquidos endovenosos ringer a 150 ml hora .
indicado seguimiento de variables hematologicas HCT - plt - funcion hepatocelular .

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

13 enero 2025 09:02 -

CUIDADO INTEGRAL DE PACIENTE CRITICO EN UCIN
TOLDILLO PARA CAMA ADULTO
CABECERA A 30°
DIETA NORMAL
MONITORÍA NO INVASIVA DE SIGNOS VITALES CADA 2 HORAS
CONTROL ESTRICTO DE LÍQUIDOS ADMINISTRADOS, ELIMINADOS, CUANTIFICAR DIURESIS
MONITORÍA EKG
PROFILAXIS ANTI TVP: NO
GASTROPROTECCIÓN: IBP
ANALGESIA: ACETAMINOFEN
ANTIMICROBIANOS/CULTIVOS: NO
CUIDADOS PROPIOS DE ENFERMERÍA Y MEDIDAS DE CONFORT
MEDIDAS DE PREVENCIÓN: HIGIENE ORAL, CUIDADOS DE PIEL, BARANDAS EN ALTO
GLUCOMETRÍA DE INGRESO.

METAS
TAM 65-75 MMHG
DIURESIS MAYOR A 0.5CC/KG/H
CONTROL DE DOLOR EVA MENOR DE 4
SATO2 MAYOR DE 9%
GLUCOMETRÍA 80-140 MG/DL

PLAN

Paciente: *09-abr.-2025 15:53*

LIQUIDOS ENDOVENOSOS RINGER A 150 ML HORA .
INDICADO SEGUIMIENTO DE VARIABLES HEMATOLOGICAS HEMOGRAMA.

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

13 enero 2025 16:03 -

Traslado a sala de hospitalización a cargo de medicina interna.

Firmado electrónicamente por -- NEFROLOGIA Tarjeta Profesional: Identificación

14 enero 2025 00:13 - *(PISO 8 (TORRE NORTE) HOSP)*

Avisar cambios a Dr(a) al tel: Dr Calderon
Baño en cama
Cabecera a 30 grados
Control de signos vitales
Control liq. admin/liq. elimin.

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

Signos Vitales

Fecha	P. A.	PAM	P. Pulm.	PPM	PVC	Temp °C	F.Card.	F. Resp	Sat O2	FIO2
11/ene./2025 13:38	118/81	93	/			37.5	95	19	96	
11/ene./2025 14:06	118/81		/			37.5	95	19	96	
11/ene./2025 19:00	126/75	92	/			36.3	71	20	98	21
11/ene./2025 21:34	117/87	97	/			36.8	89	20	98	21
12/ene./2025 01:10	132/86	101	/			36.7	85	15	97	21
12/ene./2025 06:29	128/98	108	/			36.9	89	15	98	21
12/ene./2025 09:27	115/63	80	/			36.5	63	18	97	21

Nota de Egreso

12 enero 2025 10:35 -

INGRESA PCTE DE 18 AÑOS DE EDAD CAMINANDO POR SUS MEDIOS EN COMPAÑIA DEL PADRE, PROCEDENTE DE CANDELARIA,POR CUADRO DE 4 DIAS CON CEFALEA, MIALGIAS, ARTRALGIAS, FIEBRE NO CUANTIFICADA, HIPOREXIA, NAUSEAS, VOMITO QUE CEDIÓ, DEPOSICIONES MUY BLANDAS, ACUDIÓ A PERIFERIA LE TOMARON LOS SIGUIENTES EXAMENES
10/01/2025: HEMOGRAMA: LEUCOS: 4000, N: 66.4% MON: 11.9% LINF: 21.7% HB: 17.2 GR HTO: 47.9% PLAQ: 39.000
IGM DENGUE: NEGATIVO
NS1: POSITIVO
11/01/2024: HEMOGRAMA: LEUCOS: 7100, N: 62.9% MON: 16.2% LINF: 20.9% HB: 17.9 GR HTO: 52.1% PLAQ: 23.000
NIEGA LA PRESENCIA DE SANGRADOS
MEDICO LE INDICA CONSULTAR EN NIVEL SUPERIOR

SE ATIENDE CON EPP

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

Salida

12 enero 2025 10:35 -

(Estado vital al salir **Vivo** Estado al salir Destino al salir **UCIN**

Fecha y hora de salida **15 ene. 2025 07:05** Remitido a

Medio de trasporte

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA GENERAL Tarjeta Profesional: Identificación

Signos Vitales

Fecha	P. A.	PAM	P. Pulm.	PPM	PVC	Temp °C	F.Card.	F. Resp	Sat O2	FIO2
12/ene./2025 10:48	121/69	86	/			36.3	73	21	97	21
12/ene./2025 11:33	100/65		/			36	74	16	98	
12/ene./2025 12:00	128/81	96	/			36.4	63	24	97	21
12/ene./2025 14:00	128/81	93	/			36.4	66	20	96	21
12/ene./2025 16:00	123/71	86	/			36.5	61	18	97	21
12/ene./2025 18:00	129/77	91	/			36.6	72	26	97	21
12/ene./2025 20:00	118/69	84	/			36.4	72	13	97	21

Paciente:

09-abr.-2025 15:53

	12/ene./2025 21:00	124/48	70	/				81	15	98	
	12/ene./2025 22:00	124/48	70	/			36.5	65	33	97	21
	13/ene./2025 00:00	129/74	90	/			36.3	61	13	97	21
	13/ene./2025 02:00	123/71	86	/			36.6	59	10	95	21
	13/ene./2025 04:00	132/75	91	/			36.8	64	18	93	21
	13/ene./2025 06:00	134/80	95	/			36.7	61	21	95	21
	13/ene./2025 08:00	139/85	99	/			36.6	80	32	97	21
	13/ene./2025 10:00	148/68	92	/			36.6	66	29	95	21
	13/ene./2025 12:00	134/69	89	/			37	68	21	95	21
	13/ene./2025 14:00	139/74	96	/			36.9	70	24	96	21
	13/ene./2025 16:00	135/79	95	/				64	26	96	
	13/ene./2025 18:00	149/99	114	/			36.8	64	25	96	21
	13/ene./2025 20:00			/				67	35	95	
	13/ene./2025 22:00	136/88	102	/			36.9	68	42	97	21
	13/ene./2025 23:57	129/83		/			36.6	63	24	100	
	14/ene./2025 00:05	133/81	98	/			36.2	70	18	98	21
	14/ene./2025 00:11	0/0		/			0	0	0	0	
	14/ene./2025 05:54	134/62	86	/			36.8	60	16	93	21
	14/ene./2025 09:04	142/81	101	/			36.2	95	16	94	21
	14/ene./2025 14:05	129/81	97	/			36.4	78	16	94	21
	14/ene./2025 20:25	129/71	90	/			36.2	81	16	98	21
	15/ene./2025 04:00	128/78	95	/			36.3	70	16	96	21

Salida

15 enero 2025 07:06 - *(PISO 8 (TORRE NORTE) HOSP)*

Estado vital al salir **Vivo** Estado al salir Destino al salir **Domicilio**

Fecha y hora de salida **15 ene. 2025 07:05** Remitido a

Medio de trasporte

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA INTERNA Tarjeta Profesional: Identificación

Nota de Egreso

15 enero 2025 07:07 - *(PISO 8 (TORRE NORTE) HOSP)*

Diagnósticos:
(A90X) FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO]

MEDICINA INTERNA

DIAGNOSTICOS
DENGUE CON SEROSITIS
SIGNOSDE ALARMA CORREGIDOS

PACIENTE ASINTOMATICO

EXAMEN FISICO
ALERTA
MUCOSAS HUMEDAS
SIN ESTERTORES
ABDOMEN BLANDO
SIN EDEMAS

HEMOGRAM HOY PALQUETAS EN 116.000 AYER 68.000

PLAN
PACIENTE CON DENGUE GRAVES, YA RESUELTO
SE DEFINE ERESO

Tipo Estancia: Hospitalización
Criterio: Paciente que requiera tratamiento médico prolongado con medicaciones endovenosas

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA INTERNA Tarjeta Profesional: Identificación

Signos Vitales

Paciente:)

09-abr.-2025 15:53

Fecha	P. A.	PAM	P. Pulm.	PPM	PVC	Temp °C	F.Card.	F. Resp	Sat O2	FIO2
15/ene./2025 09:00	134/77	96	/			36.4	69	19	96	21

Diagnósticos Egreso **Localización** **Tipo DX**

-- (A90X) FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO] Impresion Diagnóstica
-- (A90X) FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO] Impresion Diagnóstica
-- (A91X) FIEBRE DEL DENGUE HEMORRAGICO Impresion Diagnóstica

Firmado electrónicamente por -- MEDICINA DE URGENCIAS Tarjeta Profesional: Identificación

Control de Medicamentos

11 enero 2025 18:47 -

* 11 Ene 2025 18:49 DOLEX 500 mg TABLETA RECUBIERTA 1 GRAMO Via ORAL

Observaciones: 25CC HORA

* 11 Ene 2025 18:49 LACTATO DE RINGER SOLUCION INYECTABLE BOLSA x 1.000 mL REF:ARB2324 1000 MILILITROS Via ENDOVENOSA

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

12 enero 2025 02:01 -

Observaciones: lev lactato de ringer 150 cc/h

* 11 Ene 2025 23:11 LACTATO DE RINGER SOLUCION INYECTABLE BOLSA x 1.000 mL REF:ARB2324 150 MILILITROS Via ENDOVENOSA

Observaciones: se le administra 1 gramo via oral

* 12 Ene 2025 02:02 DOLEX 500 mg TABLETA RECUBIERTA 1 GRAMO Via ORAL

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

12 enero 2025 03:53 -

Observaciones: lev a 150 cc/ h

* 12 Ene 2025 02:00 LACTATO DE RINGER SOLUCION INYECTABLE BOLSA x 1.000 mL REF:ARB2324 150 MILILITROS Via ENDOVENOSA

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación CC 1061794190

12 enero 2025 10:20 -

* 12 Ene 2025 10:00 ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA RECUBIERTA (DOLEX 500 mg TABLETA RECUBIERTA) 1 GRAMO Via ORAL

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

12 enero 2025 16:56 -

Observaciones: INFUSION CONTINUA PLAN

* 12 Ene 2025 14:00 LACTATO RINGER 1.000 mL SOLUCION INYECTABLE (LACTATO DE RINGER SOLUCION INYECTABLE BOLSA x 1.000 mL REF:ARB2324) 1000 MILILITROS Via ENDOVENOSA

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

12 enero 2025 18:05 -

Observaciones: INFUSION CONTINUA PLAN

* 12 Ene 2025 18:06 LACTATO RINGER 1.000 mL SOLUCION INYECTABLE (LACTATO DE RINGER SOLUCION INYECTABLE BOLSA x 1.000 mL REF:ARB2324) 1000 MILILITROS Via ENDOVENOSA

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

12 enero 2025 19:00 -

* 12 Ene 2025 18:00 ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA RECUBIERTA (DOLEX 500 mg TABLETA RECUBIERTA) 1 GRAMO Via ORAL

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

13 enero 2025 02:10 -

* 13 Ene 2025 02:00 ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA RECUBIERTA (DOLEX 500 mg TABLETA RECUBIERTA) 1 GRAMO Via ORAL

Paciente: *09-abr.-2025 15:53*

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

13 enero 2025 03:35 -

* 13 Ene 2025 03:30 LACTATO RINGER 1.000 mL SOLUCION INYECTABLE (LACTATO DE RINGER SOLUCION INYECTABLE BOLSA x 1.000 mL REF:ARB2324) 1000 MILILITROS Via ENDOVENOSA

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

13 enero 2025 07:31 -

* 13 Ene 2025 10:00 ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA RECUBIERTA (DOLEX 500 mg TABLETA RECUBIERTA) 1 GRAMO Via ORAL

Observaciones: INFUSION CONTINUA

* 13 Ene 2025 10:45 LACTATO RINGER 1.000 mL SOLUCION INYECTABLE (LACTATO DE RINGER SOLUCION INYECTABLE BOLSA x 1.000 mL REF:ARB2324) 1000 MILILITROS Via ENDOVENOSA

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

13 enero 2025 17:04 -

* 13 Ene 2025 18:00 ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA RECUBIERTA (DOLEX 500 mg TABLETA RECUBIERTA) 1 GRAMO Via ENDOVENOSA

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

14 enero 2025 12:49 -

* 14 Ene 2025 12:48 ACETAMINOFÉN 500 MG TABLETA (ACETAMINOFEN 500 mg TABLETA) 1 GRAMO Via ORAL

Observaciones: PLAN

* 14 Ene 2025 12:49 LACTATO RINGER 1.000 mL SOLUCION INYECTABLE (LACTATO DE RINGER SOLUCION INYECTABLE BOLSA x 1.000 mL REF:ARB2324) 1 BOLSA Via ENDOVENOSA

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

14 enero 2025 20:51 -

* 14 Ene 2025 20:00 ACETAMINOFÉN 500 MG TABLETA (ACETAMINOFEN 500 mg TABLETA) 1 GRAMO Via ORAL

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

15 enero 2025 05:19 -

* 15 Ene 2025 04:00 ACETAMINOFÉN 500 MG TABLETA (ACETAMINOFEN 500 mg TABLETA) 1 GRAMO Via ORAL

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

15 enero 2025 11:10 -

* 15 Ene 2025 12:00 ACETAMINOFÉN 500 MG TABLETA (ACETAMINOFEN 500 mg TABLETA) 1 GRAMO Via ORAL

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

Notas de Enfermeria/Fisioterapia

11 enero 2025 01:37 -

Firmado electrónicamente por -- ENFERMERO(A) JEFE Identificación

11 enero 2025 15:27 - *(URG P1)*

ingresa paciente masculino de 18 años de edad al servicio de urgencias piso 1 adultos en compañia de familiar, se observa paciente alerta y orientada en sus tres esferas mentales recibiendo oxigeno a medio ambiente sin complicacion, sin deficit neurologico al ingreso, niega alergias a medicamentos, consulta el dia de hoy por sintomas gastrrointetinales el cual es valorado por medico de turno quien genera ordenes las cuales se verifican y se cumplen, se observa paciente con acceso venoso en miembro superior izquierdo dorso con cateter #22 conectado a valvula libre de aguja fijado con micropore limpio y seco sin signos de flebitis realizado por canalizadores de turno, queda paciente en silla reclinabele en compañia de familair, tiene pendiente reporte de paraclínicos

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

Paciente: **11 enero 2025 16:38** -

PACIENTE ES ENVIADO A LA TOMA DE ECO DE ABDOMEN TOTAL,POR LO QUE EL PACIENTE RETORNA A URGENCIAS PISO 1 A CUB 29 SE OBSERVA ESTABLE SIN NINGUNA COMPLICACION ACCESO VENOSO PERMEABLE SIN SIGNOS DE FLEBTISIS PENDIENTE RETORNO

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

11 enero 2025 19:00 -

Entregó paciente adulto en el área de observación urgencias piso 1, en camilla con barandas de seguridad elevadas, despierto, consciente, orientado en sus tres esferas, con diagnóstico anotados en HC. paciente quien pasa durante el turno aparentemente tranquilo, sin complicaciones, respirando aire ambiente, tolera vía oral, no refiere ningún tipo de dolor, con acceso venoso en miembro superior izquierdo (Dorso de la mano), con catéter número 22, con tapón libre de aguja, vena permeable sin signos de flebitis, ni infección, con manilla de identificación. deambula por sus propios medios y en compañía de su familiar, refiere que elimina espontáneo. se brindaron los cuidados de enfermería, se educa sobre los protocolos institucionales de caída y flebitis el cual refiere entender.

PENDIENTE: Toma y reporte de paraclínicos de control a las 11PM, seguir con cuidados de enfermería y nuevas órdenes médicas.
Recibo paciente de sexo masculino de 18 años de edad en el servicio de observación urgencias en camilla en el piso uno con barandas de camilla elevadas por seguridad de paciente en compañía de su familiar a paciente adulta en cuidado básico con dx anotados en historia clínica manejada medicina interna con conducta de hospitalización ,paciente quien se encuentra en estables condiciones generales despierta ,consiente orientada en sus tres esfera tiempo lugar y persona ,calmada ,colaboradora ,alerta sin alteraciones neurológicas ni respiratorias tolerando o2 al ambiente ,con reporte de eva 0/10 ,a la valoración cefalocaudal se observa paciente en buenas condiciones higiénicas y nutricionales piel pilada hidratada integra ,a nivel de miembro superior mano izquierda vena periférica permeable conectada a tapón libre de aguja fijada con tegaderm ,pasando por bombas de infusión goteo lactato de ringer a cc a 150 cc hora vena en buenas condiciones generales no signos de flebitis ni extravasación ,paciente con manilla de identificacion y tablero debidamente diligenciados con protocolo de riesgo de flebitis activado .a quien se aborda previos saludo y presentación institucional ,previas medidas dé seguridad de paciente higiene de manos paciente que se observa en buena condiones de salud que se le asiste el cuidado de enfermería y su plan farmcologico paiente que tiene controla alas 23:00 pendiente tomar se le realizan control de liquidos eliminados y administrados pendiente vigilar el estado hemodinamcio e informar cambios .

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

11 enero 2025 21:26 -

Paciente con indicacion de cateterismo vesical, Se verifica en historia clinica la indicacion. Luego de asegurar la privacidad del paciente y explicarle el procedimiento, bajo consentimiento de paciente y/o familiar se procede a procedimiento. Se ubica paciente en posicion ginecológica. Con elementos de proteccion Personal. Se realiza friccion de manos con alcohol glicerinado. Con técnica limpia se realiza asepsia de meato urinario con clorexidina solucion con movimiento de arriba hacia abajo. Con tecnica esteril se realiza insercion de sonda vesical Nelaton No. 10, previamente lubricada con lidocaina jalea elimina 350cc de orina colurica, procedimiento sin complicaciones, se informa a medico tratante.

Firmado electrónicamente por -- ENFERMERO(A) JEFE Identificación

12 enero 2025 06:29 -

Entrego paciente de sexo masculino de 18 años, en el servicio de observacion de urgencias, en la unidad 29 en camilla con barandas elevadas en posicion fowler, ubicada en sus 3 esferas: tiempo, lugar y persona, conciente, alerta, orientada, afebril, hidratada, sin dificultad respiratoria, diagnostico en evolucion medica, signos vitales estables, con acceso venoso cateter 22 mas tapon en msi mano pasando medicamnsto no se observa parte de flebitis n enrrojecimiento pasabdo lev lactato de ringer a 150 cc / h paciente que se moviliza por sus propios medios y elimina en baño el cual se encuentra con control de liquidos con acompañante permanente, news: verde, niega alergia, valoracion de eva:0, paciente niega alergias paciente que se encuentra con toldillo el cual se encuentra con contacto por vectores paciente que se moviliza por sus propios medios que se le asiste el cuidado de enfermeria y su plan farmacologico se encuentra eliminando bastastate el cual se encuentra con trol de liquidos administrado e eliminados se deja registrado todo en nota de enfermeria paciente encuentra muy activo tiene pendiente asignacion de cama el cual esta a esperar de asigaion se encuentra hospitalizado se necuentra con el integra y con petequias el cual es por sus patologia pasa buena noche estable y traquilo afebril para el turno pendiente vigilar el estado hemodinamico e informar cambios .

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

12 enero 2025 09:05 -

recibo paciente en el servicio de urgencias, consciente orientado en sus tres esferas tiempo, lugar y persona, con diagnostico anotado en la historia clínica, paciente respirando oxigeno ambiente, tolera vía oral, elimina diuresis espontaneo, no refiere dolor, piel integra, acceso venoso permeable sin signos de flebitis, se encuentra con orden de hospitalización en unidad de cuidados intermedios a cargo de medicina interna, se deja paciente con monitoria no invasiva, toldillo. paciente en compañía de familiar. pendiente autorización y asignación de cama.

Paciente:

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

12 enero 2025 18:10 - *(UCIA CUIDADO INTERMEDIO)*

Ingresa paciente a la unidad pocedente de urgencias en camilla en compañia de personal asistencial, se pasa a la cama se deja cabecera a 40°, al examen fisico se observa conciente, despierto, alerta, orientado en tiempo lugar y persona, AVDI A. region occipital integra, pabellones auriculares integro. pupilas isocóricas reactivas a la luz en talla de 2mm, tolerando oxigeno medio ambiente saturando por encima del 90%, cuello movil sin adnopatias, Tórax simétrico normo expandible conectado a monitoria cardiaca continua, no invasiva, sin esfuerzo respiratorio, Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, Miembros superiores simétricos y completos, movilidad y fuerza muscular 5/5, acceso venoso en dorso de la mano izquierda canalizado con cateter #22 (FI enero-11-2025) pasando plan ringer a 150cc/h sitio de inserción cubierto con aposito transparente limpio y seco sin signos de flebitis, pulsos radial y ulnar presentes (+++) buen llenado capilar, Genitales íntegros, eliminando espontaneo en pisingo, Region sacra, inguinal bilateral interglutea, gluteos, trocanterica bilateral integra, Miembros inferiores simétricos y completos, movilidad y fuerza muscular conservada 5/5, pulsos pedios presentes, adecuada perfusión distal y buen llenado capilar, sin edema, cama al minimo nivel de altura, barandas elevadas, colchon antiescaras funcional.

Braden: 14
EVA: 0
Alergias: NO.
Manilla en: MID
Riesgo de caída: SI
Aislamiento: NO
Limpieza de meato urinario: SI, se realiza con agua y jabón pH neutro
Higiene bucal con Clorhexidina: SI
Riesgo de LPP: Presión - Fricción - Humedad - Adhesivos
Colchón antiescaras funcional.

paciente valorado por medico y personal de enfermeria
ingresa familiar, medico y jefe dan informa sobre evolucion
recibe y tolera la via oral
paciente que pasa el turno tranquilo a febril, glucometrias entre parametros normales, recibe y tolera la via oral, fisioterapeuta realiza terapia fisica sin complicaciones, se administra tratamiento farmacologico indicado sin presentar evento adverso, se moviliza por sus medios en cama, paciente eliminando espontaneo en pisingo en abundante cantidad diuresis amarilla clara, se brindan medidas de bienestar y confort, se cumple con el plan de enfermeria.
19:00 Queda paciente en cama cabecera a 35° despierto consiente orientado en sus tres esferas AVDI (A) sin cambios en sus dispositivos medicos.

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

13 enero 2025 06:30 -

J19:00 horas del 12 - 07:00 horas del 13 de enero del 2025:
Recibo paciente en cama, cabecera a 35°, despierto, alerta, orientado en sus tres esferas mentales, glasgow 15/15, AVDI A. a la valoración física se observa región occipital integra, pabellón auricular bilateral integro, pupilas isocoricas, foto reactivas en talla de 2mm, sin soporte de oxígeno, saturando 95%, tolera y recibe la vía oral, cuello móvil, simétrico, Tórax simétrico, normo expandible, conectado a monitoria cardiaca continua, sin esfuerzo respiratorio, extremidades superiores simétricas, completas, movilidad conservada, fuerza muscular 5/5, acceso venoso en dorso de la mano del miembro superior izquierdo, canalizado con catéter periférico corto #22, sitio de inserción cubierto con apósito transparente, limpio y seco, sin signos de flebitis, permeable, recibiendo plan de líquidos en ringer a 150cc/h, pulsos radial y ulnar presentes (+++) buen llenado capilar, Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, Genitales íntegros, eliminando espontaneo en pisingo, orina amarilla clara, Región sacra, inguinal bilateral interglutea, glúteos, trocanterica bilateral integra, extremidades inferiores simétricas, completas, movilidad conservada, fuerza muscular 5/5, pulsos pedios presentes, adecuada perfusión distal y buen llenado capilar, sin edema, talones íntegros, Cama a mínimo nivel de altura, con barandas de seguridad elevadas.
BRADEN: 16
EVA: 0
ALERGIAS: NO

Paciente: 09-abr.-2025 15:53

AISLAMIENTO: NO
MANILLA DE IDENTIFICACIÓN: MIEMBRO SUPERIOR DERECHO
MANILLA DE RIEGO CAÍDA: SI
RIESGO UPP: FRICCIÓN - HUMEDAD - PRESIÓN - ADHESIVOS
LIMPIEZA DEL MEATO URINARIO: NO
HIGIENE ORAL CON CLORHEXIDINA: NO.
RIESGO DE CAÍDA: SE DAN RECOMENDACIONES AL PACIENTE Y FAMILIA SOBRE LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS, CAMA CON BARANDAS ELEVADAS, CAMA CON EL NIVEL BAJO DE ALTURA, PACIENTE CON MANILLA DE COLOR LILA, SIN SUJECIÓN MECÁNICA PREVENTIVA, CON ALARMAS DE MONITOR ENCENDIDAS Y TIMBRE DE LLAMADO CERCA.
Paciente a quien durante el turno se le brinda medidas de bienestar y confort, colabora con los cambios de posición, se le realiza lubricación de piel con crema humectante y aplicación de crema a base de óxido de zinc en área de pañal. Verificación y funcionamiento de colchón anti escaras, Liberación de presión protección de prominencias Oseas, Uso de removedor de adhesivos, Utilización de protectores de piel antes de poner adhesivos. Se administra tratamiento farmacológico indicado, no se presentan eventos adversos. Glucometrias entre los parámetros establecidos, no hace deposición, elimina espontaneo en adecuada cantidad. Duerme intervalos largos de tiempo. Pasa hemodinamicamente estable, a febril, en compañía de familiar.
07:00 horas. Queda paciente en cama, cabecera 35°, despierto, consciente, orientado en sus tres esferas mentales, Glasgow de 15/15. Sin cambios en sus dispositivos médicos

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

13 enero 2025 16:44 -

SEGUIMIENTO GRUPO DE CATÉTER VENOSO SEGURO
Se realiza ronda de seguimiento del programa de catéter seguro, se valora paciente con vena periférica #22G ubicado en dorso de mano izquierda con apósito pediátrico integro, con fecha de inserción del día 1 de enero, sitio de inserción limpio, sin signos de humedad, sangrado, ni flebitis, escala de MADDOX 0. Se informa a jefe de turno.

Firmado electrónicamente por -- Tarjeta Profesional: - Identificación

13 enero 2025 18:14 -

07:00 Recibo paciente en cama, cabecera a 35°, despierto, alerta, orientado en sus tres esferas mentales, glasgow 15/15, AVDI A. a la valoración física se observa región occipital integra, pabellón auricular bilateral integros, pupilas isocoricas, foto reactivas en talla de 2mm, sin soporte de oxígeno, saturando superando mayor a 90%, tolera y recibe la vía oral, cuello móvil, simétrico, Tórax simétrico, normo expandible, conectado a monitoria cardiaca continua, sin esfuerzo respiratorio, extremidades superiores simétricas, completas, movilidad conservada, fuerza muscular 5/5, acceso venoso en dorso de la mano del miembro superior izquierdo, canalizado con catéter periférico corto #22, sitio de inserción cubierto con apósito transparente, limpio y seco, sin signos de flebitis, permeable, recibiendo plan de líquidos en ringer a 150cc/h, pulsos radial y ulnar presentes (+++) buen llenado capilar, Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, Genitales íntegros, eliminando espontaneo en pisingo, orina amarilla clara, Región sacra, inguinal bilateral interglutea, glúteos, trocanterica bilateral integra, extremidades inferiores simétricas, completas, movilidad conservada, fuerza muscular 5/5, pulsos pedios presentes, adecuada perfusión distal y buen llenado capilar, sin edema, talones íntegros, Cama a mínimo nivel de altura, con barandas de seguridad elevadas.
BRADEN: 16
EVA: 0
ALERGIAS: NO
AISLAMIENTO: NO
MANILLA DE IDENTIFICACIÓN: MIEMBRO SUPERIOR DERECHO
MANILLA DE RIEGO CAÍDA: SI
RIESGO UPP: FRICCIÓN - HUMEDAD - PRESIÓN - ADHESIVOS
LIMPIEZA DEL MEATO URINARIO: NO
HIGIENE ORAL CON CLORHEXIDINA: NO.
RIESGO DE CAÍDA: SE DAN RECOMENDACIONES AL PACIENTE Y FAMILIA SOBRE LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS, CAMA CON BARANDAS ELEVADAS, CAMA CON EL NIVEL BAJO DE ALTURA, PACIENTE CON MANILLA DE COLOR LILA, SIN SUJECIÓN MECÁNICA PREVENTIVA, CON ALARMAS DE MONITOR ENCENDIDAS Y TIMBRE DE LLAMADO CERCA

08:00 Se realiza baño húmedo en cama con paños institucionales, higiene ocular, higiene oral con cepillado, higiene del meato urinario con agua y jabon, se cambian tendidos, se hace hidratación de la piel se administro tratamiento medico farmacológico ingiere y tolera su alimentación sin complicaciones

Paciente: 09-abr.-2025 15:53

12:00 glucometrias de control de 101 mg/dl ingiere y tolera alimentacion sin complicaciones.
paciente hemodinamicamente estable, se encuenta en compañia de familiar elimina espontaneo tolerando tratamiento farmacologico sin ningun evento adverso.
Se realiza curacion de acceso venoso periferico.
Jefe de turno toma paraclinicos de control,

16:00 Paciente hemodinamicamente con TAM entre 80-100 mmhg FC entre 60-80 Lxmin, afebril, , tranquilo, acompañado de familiar.
Es valorado por medico de la sala, e indica disminuir plan de liquidos a 50cchora, y ordena traslado a piso, pendiente disponibilidad de la cama.

18:00 Administro tratamiento medico farmacológico.
Realizo irrigación de dispositivo invasivo con jeringa prellena con técnica paro y empujo, permeable.

19:00 Queda paciente en cama, con familiar, estado de dispositivos invasivos en adecuadas condiciones, elimino espontaneo, no realiza deposición, sin cambios en sus dispositivos invasivos. Pendiente disponibilidad de la cama en hospitalizacion.

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

14 enero 2025 00:00 -

19:00 Recibo paciente en cama, cabecera a 35°, despierto, alerta, orientado en sus tres esferas mentales, glasgow 15/15, AVDI A. a la valoración física se observa región occipital integra, pabellón auricular bilateral integros, pupilas isocoricas, foto reactivas en talla de 2mm, sin soporte de oxígeno, saturando superando mayor a 90%, tolera y recibe la vía oral, cuello móvil, simétrico, Tórax simétrico, normo expandible, conectado a monitoria cardiaca continua, sin esfuerzo respiratorio, extremidades superiores simétricas, completas, movilidad conservada, fuerza muscular 5/5, acceso venoso en dorso de la mano del miembro superior izquierdo, canalizado con catéter periférico corto #22, sitio de inserción cubierto con apósito transparente, limpio y seco, sin signos de flebitis, permeable, recibiendo plan de líquidos en ringer a 50 cc/h, pulsos radial y ulnar presentes (+++) buen llenado capilar, Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, Genitales íntegros, eliminando espontaneo en pisingo, orina amarilla clara, Región sacra, inguinal bilateral interglutea, glúteos, trocanterica bilateral integra, extremidades inferiores simétricas, completas, movilidad conservada, fuerza muscular 5/5, pulsos pedios presentes, adecuada perfusión distal y buen llenado capilar, sin edema, talones íntegros, Cama a mínimo nivel de altura, con barandas de seguridad elevadas.
BRADEN: 16
EVA: 0
ALERGIAS: NO
AISLAMIENTO: NO
MANILLA DE IDENTIFICACIÓN: MIEMBRO SUPERIOR DERECHO
MANILLA DE RIEGO CAÍDA: SI
RIESGO UPP: FRICCIÓN - HUMEDAD - PRESIÓN - ADHESIVOS
LIMPIEZA DEL MEATO URINARIO: NO
HIGIENE ORAL CON CLORHEXIDINA: NO.
RIESGO DE CAÍDA: SE DAN RECOMENDACIONES AL PACIENTE Y FAMILIA SOBRE LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS, CAMA CON BARANDAS ELEVADAS, CAMA CON EL NIVEL BAJO DE ALTURA, PACIENTE CON MANILLA DE COLOR LILA, SIN SUJECIÓN MECÁNICA PREVENTIVA, CON ALARMAS DE MONITOR ENCENDIDAS Y TIMBRE DE LLAMADO CERCA

Durante el turno paciente permanece tranquilo, estable, recibe y tolera via oral y tratamiento farmacologico, se moviliza por sus medios, se le toman laboratorios y glucometrias de control, pasa el turno sin complicaciones.
00:00 Hrs Se traslada paciente a piso en silla de ruedas en compañia de camillero, familiar y auxiliar sin complicaciones.

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

14 enero 2025 06:44 -

24:05 ingresa paciente de uci en silla de ruedas, acompañado de familiar, mensajero y auxiliar, se ubica en la habitacion por sus medios, se encuentra despierto, consiente, orientado en sus tres esferas mentales, tolerando oxígeno al medio ambiente, acceso venoso en dorso de la mano izquierda, cubierto con apósito transparente, limpio y seco, sin signos de flebitis, con fecha de inserccion del 11-01-25 permeable, pasando hartman a 50 cc/h, Abdomen blando, elimina espontaneo en pisingo, moviliza extremidades, piel integra.
24:20 se realiza toma de signos vitales los cuales se encuentran dentro de parametros normales, no refiere dolor, Se dan

Paciente: 09-abr.-2025 15:53

recomendaciones a familiar sobre la prevención de caídas, por ello se les indica que el paciente tiene manilla de identificación con un Sticker color lila que lo identifica como paciente con riesgo de caída, se le explica que debe mantener la cama SIEMPRE en el nivel más bajo, las barandas de la cama SIEMPRE arriba y que debe usar el timbre de llamado de familiar sobre la importancia del autocuidado del paciente y seguir las medidas preventivas.
durante la noche pasa tranquila en cama se moviliza por sus medios, recibe y tolera la via oral, no refiere dolor, auxiliar correspondiente le administra medicamentos ordenados sin complicaciones, elimina espontaneo 400cc, no realiza deposicion.
05:00 se realiza toma de signos vitales los cuales se encuentran dentro de parametros normales, no refiere dolor
07:00 queda paciente en cama con barandas arriba, acompañada de familiar, sin cambios por el momento

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

14 enero 2025 07:20 -

Recibo paciente de 18 años de edad masculino en el servicio de Hospitalización en cama cuatro barandas de seguridad elevadas en compañía de familiar, DX: anotado en historia clínica, a la valoración física se observa despierta, consciente y orientada en sus tres esferas mentales tiempo, lugar y persona, apertura ocular espontanea, tolerando oxígeno al medio ambiente sin signos de dificultad respiratoria, adecuada respuesta verbal y motora, cuello móvil, tórax simétrico, acceso periférico dorso mano izquierdo FI 11/01/2025 cubierto con tegaderm limpio y seco permeable pasando L ringer a 50cch y medicamentos ordenados, abdomen blando no doloroso a la palpación, eliminación espontanea respectivo control de líquidos, cuatro extremidades presentes, se moviliza por sus propios medios sin dificultad.

9:00am se realiza toma de signos vitales los cuales se encuentran dentro de los parámetros normales y se registran en el sistema, no refiere dolor en el momento, tolerando vía oral y tratamiento médico ordenado, pendiente a cambios.

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

14 enero 2025 10:32 -

Se ingresa a la habitación se brindan medidas de aseo y confort para paciente y habitación para aseo personal paciente refiere que no desea pasar a la ducha el día de hoy, solo permite el cambio de ropa de cama, se reeduca a paciente sobre riesgo de caída, debido desecho de los residuos, derechos y deberes de paciente, rutas de educación y horarios de visita refieren entender, se hace firmar riesgo de caída por familiar.

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

14 enero 2025 18:51 -

Entrego paciente en el servicio de hospitalización en cama cuatro barandas de seguridad elevadas y nivel mas bajo, despierto, consciente y orientado en sus tres esferas mentales, durante el dia pasa tranquilo deambula en habitación y fuera de ella en compañía de familiar y fisioterapeuta, no presento cambios se realiza toma de signos vitales en la mañana y la tarde en parámetros normales se registran en el sistema, durante la mañana se brindan medidas de aseo y confort a paciente y habitación, se reeduca a familiar la importancia de timbre de llamado derechos y deberes, riesgo de caída, eliminación espontanea respectivo control de líquidos, a realizado deposición, acceso periférico permeable para medicamentos ordenados, pendiente a cambios.

CONTROL DE LIQUIDOS DE 12 HORAS.

ADMINISTRADOS: 2270 CC.
ELIMINADOS:2000 CC.
BALANCE: +270CC.
GASTO:1.8 KG

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

15 enero 2025 05:52 -

19+05:recibo paciente adulto joven , acostado en cama con barandas arriba , en compañia de familiar ,despierto , alerta al llamado , orientado en sus tres esferas , tolerando oxigeno al medio ambiente , extremidades complets y moviles canalizado en antebrazo izquierdo con liquidos permanentes cubierto limpio y seco permeable , abdomen depresible no doloroso a la palpacion , eliminando espontaneo , se moviliza sin limitaciones

20+30: se realiza control de signos vitales se brinda confort , se reeduca sobre los riesgos de caida - flebitis - importancia al uso del llamado de enfermeria y el acompañante las 24 horas . recibe y tolera tto medico indicado

04+30 se pasa nueva ronda por unidad de paciente se realiza control de signos vitales los cuales registro en el sistema, recibe y tolera tto medico indicado , paciente refiere dormir por intervalos largos sin presentar alteraciones refeire mejoria del dolor
06+45: entrego paciente adulto joven en cama con barandas elevadas en compañia de su familiar sin referir cambios durate la noche

Paciente: 09-abr.-2025 15:53

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA

15 enero 2025 10:30 -

07 horas
recibo paciente mayor de edad , acostado en cama , con barandas arriba , en compañia de familiar ,despierto ,alerta al llamado , tolerando oxigeno al medio ambiente , acceso venoso periférico en dorso de mano izquierda del dia 11 catéter corto calibre 22 pasando ringer a 50 cc hora por bomba de infusión permeable maddox 0 , equimosis en miembros superiores, abdomen depresible no doloroso a la palpación , eliminando espontaneo , ambulatorio.

se realiza control de signos vitales- se reportan a jefe de turno , news de 1 , eva 0/10 , se brinda confort , se dan recomendaciones del servicio de hospitalización , se reeduca sobre los riesgos de upp - caída - flebitis - importancia al uso del llamado de enfermería y el acompañante las 24 horas .

recibe medicamentos ordenados , vía oral , elimina espontaneo , no realiza deposición , se moviliza cama por sus propios medios , deambula por la habitación , se realiza baño en ducha por sus propios medios evitando filtrar agua a dispositivos invasivos y herida qx - se cambian tendidos de cama / recibe valoración por especialista quien da orden de egreso , jefe realiza entrega de ordenes medicas , solucionando dudas e inquietudes e informan signos de alarma para consultar por urgencias , familiar y paciente refieren entender , se retira acceso venoso , pendiente que la abuela la cual es la acompañante en el momento informa que están espera al padre del paciente .

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

15 enero 2025 10:54 -

paciente es llevado en silla de ruedas en compañia de familiares y mensajero a piso 0 para traslado a domicilio , sale tranquilo , estable , tolerando oxigeno al medio ambiente , sin acceso venoso , equimosis en miembros superiores , abdomen depresible no doloroso al momento , eliminando espontaneo , hasta el momento sin ningún tipo de sangrado , piel integra , glasgow 15/15 , moviliza sus cuatro extremidades , ambulatorio .

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

Procedimiento de Fisioterapeuta

12 enero 2025 11:43 -

Paciente con Acompañante: : No
Fecha y Hora: : 12/01/2025 11:43:08 a. m.
Descripción : SOPORTE DE OXÍGENO INICIAL: AIRE AMBIENTE
SOPORTE DE OXIGENO FINAL : AIRE AMBIENTE

DIAGNÓSTICO MÉDICO:
1. DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA
- DOLOR ABDOMINAL.

ANTECEDENTES: NIEGA

DIAGNOSTICO FISIOTERAPEUTICO:
DOMINIO CARDIOVASCULAR PULMONAR: PATRÓN A, DOMINIO MUSCULOESQUELÉTICO: PATRÓN A, PACIENTE MASCULINO DE 18 AÑOS EDAD CON DIAGNÓSTICO MÉDICO DE DENGUE CPN SIGNOS DE ALARMA, NO PRESENTA EN EL MOMENTO DEFICIENCIAS QUE COMPROMETEN EL SISTEMA CARDIOVASCULAR PULMONAR Y OSTEOMUSCULAR, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y PULMONAR AL IGUAL QUE LA REDUCCIÓN DE FACTORES DE RIESGO PARA DESMINERALIZACIÓN ÓSEA. PACIENTE EN EL MOMENTO PRESENTA LIMITACIÓN LEVE EN LAS ACTIVIDADES BÁSICAS COTIDIANAS COMO AUTOCUIDADO, ACTIVIDADES INSTRUMENTALES COMO CAMINAR LARGAS DISTANCIAS, Y POR HOSPITALIZACIÓN PRESENTA RESTRICCIÓN COMPLETA EN LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL.

SIGNOS VITALES:
TENSION ARTERIAL: 128/81 (96) MMHG
FRECUENCIA CARDIACA: 74 LPM
FRECUENCIA RESPIRATORIA: 18 RPM
SATURACIÓN DE O2: 97%
ESCALA DE BORG:0/10
ESCALA DE EVA: 0/10

EVALUACION:
PACIENTE EN CONTEXTO DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA EN FASE CRÍTICA, NS1 POSITIVO, DIA 4 , HOY PLAQUETAS DE 19.000 PREVIAS DE P´LAQ: 23.000, HCT 48% ,TRANSAMINITIS, INR LIMITE SUPERIOR , (ALTO

RIESGO DISFUNCION HEPATOCELULAR) , SIN MANIFESTACION DE SANGRADO , VARIABLES MACRO - HEMODINAMICAS EN METAS . SE INDICA RENIMACION DIRIGIDA POR VOLUMEN ,INDICADO SEGUIMIENTO DE VARIABLES HEMATOLOGICAS HCT - PLT - FUNCION HEPATOCELULAR . TOLDILLO PARA CAMA ADULTO . MONITORIA UCIN.

INSPECCIÓN: RESPIRACIÓN DE TIPO COSTAL SUPERIOR SUPERFICIAL, RÍTMICO, NO SE EVIDENCIA SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA.
PARÁMETROS VENTILATORIOS: NA
POSICIÓN, FIJACIÓN Y PRESIÓN CUFF DEL TOT/TQT: NA
N° TRAQUEOSTOMÍA: NA
KIT TRAQUEOSTOMIA: COMPLETO/INCOMPLETO: NA
OCLUSIÓN DE TQT: NA
PALPACIÓN: SIN ALTERACIONES
AUSCULTACIÓN: MURMULLO VESICULAR PRESENTE EN AMBOS CAMPOS PULMONARES SIN PRESENCIA DE RUIDOS SOBREAGREGADOS.
GASES ARTERIALES: PaO2: CO2: HCO3: BE: SvO2: PaO2/FIO2: FIO2: NA
INTERPRETACION GASES: NA
MEDICAMENTOS TERAPÊUTICOS: NA
EXÁMENES Y AYUDAS DIAGNÓSTICAS: YA DESCRITOS.

OBJETIVOS TERAPEUTICOS:
MONITOREO Y VIGILANCIA RESPIRATORIA
MONITOREO Y VIGILANCIA HEMODINÁMICA

EVOLUCIÓN:
PACIENTE EN EL MOMENTO TRANQUILO, VENTILATORIAMENTE ESTABLE, CON ADECUADA SATURACIÓN Y SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, SE REALIZA EVALUACIÓN PERTINENTE, MONITOREO, VIGILANCIA HEMODINÁMICA Y RESPIRATORIA DURANTE INGRESO. AL FINALIZAR SE DEJA PACIENTE EN SEMIFOWLER EN CAMA CON BARANDAS ARRIBA Y CAMA NIVEL MÁS BAJO, CON MANILLA LILA Y TIMBRE A LA MANO Y MONITOREO PERMANENTE.

SE REFUERZA EDUCACIÓN SOBRE PREVENCIÓN Y RIESGO DE CAÍDAS, SE DA RECOMENDACIÓN DE MANTENER CAMA A NIVEL MÁS BAJO , BARANDAS ARRIBA, MANTENER MANILLA LILA Y EVITAR CAMBIOS DE POSICIÓN Y TRANSICIONES SIN ASISTENCIA DE PERSONAL CLÍNICO, PACIENTE REFIERE ENTENDER.

INSUMOS:NO
AYUDAS TERAPÉUTICAS: NO

Firmado electrónicamente por -- FISIOTERAPIA Tarjeta Profesional: Identificación

12 enero 2025 18:21 -

Paciente con Acompañante: : No
Fecha y Hora: : 12/01/2025 06:18:50 p. m.
Descripción : SOPORTE DE OXÍGENO INICIAL: SIN SOPORTE DE O2.
SOPORTE DE OXIGENO FINAL : SIN SOPORTE DE O2.

DIAGNÓSTICO MÉDICO:
1. DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA
- DOLOR ABDOMINAL.

ANTECEDENTES: NIEGA

DIAGNOSTICO FISIOTERAPEUTICO:
DOMINIO CARDIOVASCULAR PULMONAR: PATRÓN A, DOMINIO MUSCULOESQUELÉTICO: PATRÓN A, PACIENTE MASCULINO DE 18 AÑOS EDAD CON DIAGNÓSTICO MÉDICO DE DENGUE CPN SIGNOS DE ALARMA, NO PRESENTA EN EL MOMENTO DEFICIENCIAS QUE COMPROMETEN EL SISTEMA CARDIOVASCULAR PULMONAR Y OSTEOMUSCULAR, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y PULMONAR AL IGUAL QUE LA REDUCCIÓN DE FACTORES DE RIESGO PARA DESMINERALIZACIÓN ÓSEA. PACIENTE EN EL MOMENTO PRESENTA LIMITACIÓN LEVE EN LAS ACTIVIDADES BÁSICAS COTIDIANAS COMO AUTOCUIDADO, ACTIVIDADES INSTRUMENTALES COMO CAMINAR LARGAS DISTANCIAS, Y POR HOSPITALIZACIÓN PRESENTA RESTRICCIÓN COMPLETA EN LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL.

SIGNOS VITALES:
FRECUENCIA CARDIACA: 62 LPM
FRECUENCIA RESPIRATORIA: 18 RPM

Paciente: 09-abr.-2025 15:53

SATURACIÓN DE O2: 90%
ESCALA DE BORG :0/10
ESCALA DE EVA: 0/10
EVALUACION: PACIENTE EN CONTEXTO DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA EN FASE CRÍTICA, NS1 POSITIVO, DIA 4 , HOY PLAQUETAS DE 19.000 PREVIAS DE P´LAQ: 23.000, HCT 48% ,TRANSAMINITIS, INR LIMITE SUPERIOR , (ALTO RIESGO DISFUNCION HEPATOCELULAR) , SIN MANIFESTACION DE SANGRADO , VARIABLES MACRO - HEMODINAMICAS EN METAS . SE INDICA RENIMACION DIRIGIDA POR VOLUMEN ,INDICADO SEGUIMIENTO DE VARIABLES HEMATOLOGICAS HCT - PLT - FUNCION HEPATOCELULAR . TOLDILLO PARA CAMA ADULTO . MONITORIA UCIN.
AL EXAMEN FISICO, PACIENTE CONCIENTE, TRANQUILO, PERMANECE CON REPOSO EN CAMA Y TOLDILLO, SIN SOPORTE DE O2, NI HEMODINAMICO, REANIMACION CON LEVS.
INSPECCIÓN: RESPIRACIÓN DE TIPO COSTAL SUPERIOR SUPERFICIAL, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA.
PARÁMETROS VENTILATORIOS: NA
POSICIÓN, FIJACIÓN Y PRESIÓN CUFF DEL TOT/TQT: NA
N° TRAQUEOSTOMÍA: NA
KIT TRAQUEOSTOMIA: COMPLETO/INCOMPLETO: NA
OCLUSIÓN DE TQT: NA
PALPACIÓN: SIN ALTERACIONES
AUSCULTACIÓN: MURMULLO VESICULAR PRESENTE EN AMBOS CAMPOS PULMONARES SIN PRESENCIA DE RUIDOS SOBREAGREGADOS.
GASES ARTERIALES: PaO2: CO2: HCO3: BE: SvO2: PaO2/FIO2: FIO2: NA
INTERPRETACION GASES: NA
MEDICAMENTOS TERAPÊUTICOS: NA
EXÁMENES Y AYUDAS DIAGNÓSTICAS: YA DESCRITOS.

OBJETIVOS TERAPEUTICOS:
VIGILANCIA RESPIRATORIA.

Firmado electrónicamente por -- FISIOTERAPIA Tarjeta Profesional: Identificación

13 enero 2025 17:43 -

Paciente con Acompañante: : No
Fecha y Hora: : 13/01/2025 02:00:00 p. m.
Descripción : SOPORTE DE OXÍGENO INICIAL: SIN SOPORTE DE O2.
SOPORTE DE OXIGENO FINAL : SIN SOPORTE DE O2.

DIAGNÓSTICO MÉDICO:
1. DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA
- DOLOR ABDOMINAL.
2. HEPATITIS POR DENGUE

ANTECEDENTES: NIEGA

DIAGNOSTICO FISIOTERAPEUTICO:
DOMINIO CARDIOVASCULAR PULMONAR: PATRÓN A, DOMINIO MUSCULOESQUELÉTICO: PATRÓN A, PACIENTE MASCULINO DE 18 AÑOS EDAD CON DIAGNÓSTICO MÉDICO DE DENGUE CPN SIGNOS DE ALARMA, NO PRESENTA EN EL MOMENTO DEFICIENCIAS QUE COMPROMETEN EL SISTEMA CARDIOVASCULAR PULMONAR Y OSTEOMUSCULAR, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y PULMONAR AL IGUAL QUE LA REDUCCIÓN DE FACTORES DE RIESGO PARA DESMINERALIZACIÓN ÓSEA. PACIENTE EN EL MOMENTO PRESENTA LIMITACIÓN LEVE EN LAS ACTIVIDADES BÁSICAS COTIDIANAS COMO AUTOCUIDADO, ACTIVIDADES INSTRUMENTALES COMO CAMINAR LARGAS DISTANCIAS, Y POR HOSPITALIZACIÓN PRESENTA RESTRICCIÓN COMPLETA EN LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL.

SIGNOS VITALES:
FRECUENCIA CARDIACA: 69 LPM
FRECUENCIA RESPIRATORIA: 26 RPM
SATURACIÓN DE O2: 96%
ESCALA DE BORG :0/10
ESCALA DE EVA: 0/10
EVALUACION: Paciente de 18 años de edad en primer dia de internación en UCIN. Tiene dengue con signos de alarma en fase crítica. NS1 positivo hoy dìa 5. Trombocitopenia severa obligó a manejo en unidad intensiva, sin embargo exhibe mejorìa progresiva. Se hará control hemograma en la tarde, se continúa hidratación. Vigilancia clínica y riesgo de sangrado le hacen meritorio de vigilancia en intermedia como se ha descrito.
AL EXAMEN FISICO, PACIENTE CONCIENTE, TRANQUILO, PERMANECE CON REPOSO EN CAMA Y TOLDILLO, SIN

Paciente: *09-abr.-2025 15:53*

SOPORTE DE O2, NI HEMODINAMICO, REANIMACION CON LEVS.
INSPECCIÓN: RESPIRACIÓN DE TIPO COSTAL SUPERIOR SUPERFICIAL, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA.
PARÁMETROS VENTILATORIOS: NA
POSICIÓN, FIJACIÓN Y PRESIÓN CUFF DEL TOT/TQT: NA
N° TRAQUEOSTOMÍA: NA
KIT TRAQUEOSTOMIA: COMPLETO/INCOMPLETO: NA
OCLUSIÓN DE TQT: NA
PALPACIÓN: SIN ALTERACIONES
AUSCULTACIÓN: MURMULLO VESICULAR PRESENTE EN AMBOS CAMPOS PULMONARES SIN PRESENCIA DE RUIDOS SOBREAGREGADOS.
GASES ARTERIALES: PaO2: CO2: HCO3: BE: SvO2: PaO2/FIO2: FIO2: NA
INTERPRETACION GASES: NA
MEDICAMENTOS TERAPÊUTICOS: NA
EXÁMENES Y AYUDAS DIAGNÓSTICAS: YA DESCRITOS.

OBJETIVOS TERAPEUTICOS:
VIGILANCIA RESPIRATORIA.

Firmado electrónicamente por -- FISIOTERAPIA Tarjeta Profesional: Identificación

13 enero 2025 17:46 -

Paciente con Acompañante: : No
Fecha y Hora: : 13/01/2025 02:00:00 p. m.
Descripción : PACIENTE QUE POR SU ENFERMEDAD EN GENERAL, DEBE GUARDAR REPOSO EN CAMA, EN AISLAMIENTO CON TOLDILLO.

Firmado electrónicamente por -- FISIOTERAPIA Tarjeta Profesional: Identificación

Nota Egreso Enfermería

15 enero 2025 10:54 -

paciente es llevado en silla de ruedas en compañia de familiares y mensajero a piso 0 para traslado a domicilio , sale tranquilo , estable , tolerando oxigeno al medio ambiente , sin acceso venoso , equimosis en miembros superiores , abdomen depresible no doloroso al momento , eliminando espontaneo , hasta el momento sin ningún tipo de sangrado , piel integra , glasgow 15/15 , moviliza sus cuatro extremidades , ambulatorio .

Firmado electrónicamente por -- AUXILIAR DE ENFERMERIA Identificación

Firmado Electrónicamente por

Identificación
Especialidad
Tarjeta Profesional